

Bijlage 10: Overzicht Gericht Contracteren GGZ

Dit document bevat de richtlijnen en voorwaarden voor zorgaanbieders die willen deelnemen aan ‘Gericht Contracteren GGZ 2027-2029’.

Passend aanbod voor complexe problematiek.

Zorgaanbieders hebben op basis van de Regiokaart Complex hiaten in het zorgaanbod in de regio in beeld gebracht. Daarbij is aangegeven of hier extra aanbod voor nodig is. Met gericht contracteren faciliteert Zilveren Kruis dit extra aanbod en willen we de hiaten in het zorgaanbod daarmee opvullen. Het doel is om gezamenlijk passende zorg te realiseren voor mensen met een complexe zorgvraag, juist op die plekken waar deze nu ontbreekt. Uit de regiokaart blijkt dat voor 3 doelgroepen in bijna alle Zilveren Kruis regio's een knelpunt bestaat. Omdat het niet altijd mogelijk is om dit aanbod in iedere regio te realiseren, zetten we deze vraag bovenregionaal uit.

Gericht contracteren gaat over de volgende drie doelgroepen.

- Prikkelarm wonen
- Psychiatrische verpleeghuiszorg
- Besloten wonen

In deze bijlage beschrijven wij per doelgroep het profiel, het benodigde milieu en de expertise. Bij beoordeling van het plan van aanpak toetsen wij in hoeverre het plan hierbij aansluit. In onderstaande tabel staan het aantal plaatsen en om welke gebieden het gaat. De exacte omvang van de noodzakelijke capaciteit is moeilijk vast te stellen. Daarom zijn wij in 2024 gestart met aantallen waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat de behoefte regio-overstijgend bestaat. Voor een deel zijn er in de afgelopen jaren al plannen van aanpak opgesteld. Voor het andere deel is nog behoefte aan nieuwe plannen. Het gaat om de aantallen in onderstaande tabel. U kunt een voorstel indienen voor (een deel van) de gewenste plekken. Of voor meer plekken, als u de behoefte cijfermatig onderbouwt.

De gebieden voor gericht contracteren bestaan uit:

- **West:** Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam
- **Midden:** Utrecht, 't Gooi, Almere, Flevoland, Apeldoorn-Zutphen
- **Noord:** Friesland, Drenthe, Zwolle

Belangrijk om te weten is dat er vanuit de regiokaart complex ook initiatieven uit de regio naar voren komen voor andere doelgroepen dan beschreven staan in deze bijlage. Deze kunnen ook in aanmerking komen voor gericht contracteren. U kunt uw voorstel tot 1 juli kenbaar maken bij uw inkoopteam; dit hoeft niet via VECOZO. Wij passen de focus op doelgroepen jaarlijks aan wanneer dat nodig is.

Planning.

- 1 juli: maak voor deze datum bij het inkoopteam uw interesse voor gericht contracteren kenbaar.
- 1 sept: lever voor deze datum een plan van aanpak aan bij uw inkoopteam.
- 1sept/ 31 okt: in deze periode bespreken we uw plan van aanpak.
- 1 dec: we maken een definitieve selectie van initiatieven voor deze datum.

Geprioriteerde doelgroepen.

A. Prikkelarm wonen.

Profiel van deze klantgroep. Kenmerken kunnen voorkomen, maar hoeven niet allemaal aanwezig te zijn.

- Vaak is er sprake van triple problematiek: een psychiatrische aandoening (vaak een EPA-diagnose), verslaving en een LVB of zwakbegaafdheid (IQ < 85).
- Er is altijd een combinatie van stoornissen. Deze kunnen somatisch, psychisch en sociaal of maatschappelijk van aard zijn. Een deel van de klanten heeft (tijdelijk) intensieve geestelijke en somatische zorg nodig. Zij zijn vaak niet in staat deze hulp zelf in te roepen of accepteren de hulp moeilijk.
- Er is sprake van (hoogfrequent) probleemgedrag zowel externaliserend en internaliserend. Dit hangt bijvoorbeeld samen met een beperkt empathisch vermogen, weinig ziekte-inzicht, onvoldoende inzicht in oorzaak en gevolg of met overvraging en onderschatting.
- Vaak is de frustratietolerantie laag. In sommige gevallen uit zich dit in uit-agerend gedrag.

Kenmerken van het milieu/de context.

- Prikkelarme, duidelijke en voorspelbare omgeving (buiten de wijk).
- Kleinschalige woonvoorziening afhankelijk van locatie en mogelijkheid tot clustering met max. 14 klanten.
- Zelfstandige woonunits om groepsspanningen te vermijden (geen groepsdruk).
- Participatie/sociale verplichtingen in overeenstemming met (beperkte) draagkracht.
- Prikkelarme activiteiten, individueel of in kleine rustige groepen.
- Er is 24/7 zorg aanwezig.
- Maatwerkmogelijkheden afgestemd op specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte, zonder behandeldruk.
- Samenwerking met ketenpartners, zoals gemeente, politie of reclassering. En vangnetmogelijkheden geborgd in de werkwijze en samenwerkingsafspraken.
- Middelengebruik is geen contra-indicatie (ontmoedigingsbeleid).
- Levensbestendige woningen ('vandalismebestendig').

Deze expertise is nodig.

- De basishouding van de zorgverlener is gebaseerd op acceptatie van de klant en het kijken naar wat wél kan, vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid.
- Kennis van en ervaring met mensen met ernstige multi-problematiek op alle levensgebieden.
- Vroegsignaleringsmethoden.
- De-escalerend kunnen werken en omgaan met agressie.
- Beschikbaarheid AVG/psychiater vanuit multidisciplinair team.

B. Psychiatrische verpleeghuiszorg/ wonen met intensieve somatische ondersteuning.

Profiel van deze klantgroep (kenmerken kunnen, maar hoeven niet allemaal aanwezig te zijn)

- Leeftijd over het algemeen 50+.
- De somatische zorgvraag is groter dan de begeleidingsvraag (zorgprofiel W4).
- Naast de somatische hulpvraag is er sprake van een complexe combinatie van psychische en sociaal maatschappelijke problematiek, waarbij vaak sprake is van triple problematiek (LVB, GGZ en verslaving) en middelengebruik aanwezig is.

Kenmerken van het milieu/de context.

- Er zijn 24/7 medewerkers met een zorgopleiding aanwezig.
- Rolstoeltoegankelijke voorziening, zelfstandige woonruimtes.
- In het gebouw is rekening gehouden met minder mobiele klanten. Bijvoorbeeld voldoende ruimte in de kamer voor hulpmiddelen, bredere deuropeningen voor rolstoelgebruik en de aanwezigheid van een lift.
- Veel nabijheid om toenemende onrust en angst zoveel mogelijk vroegtijdig te signaleren.
- Beschikbaarheid verslavingsexpertise vanuit het multidisciplinaire team.
- Participatie/sociale verplichtingen in overeenstemming met (beperkte) draagkracht.
- Maatwerkmogelijkheden waarbij zorg en begeleiding zijn afgestemd op specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte.

- Er is samenwerking met ketenpartners zoals gemeente, politie en reclassering en de werkwijze borgt vangnetmogelijkheden in afspraken en uitvoering.
- Gericht op wat nog wel kan, behoud van vaardigheden.
- Mogelijkheid bestaat om op indicatie besloten zorg te leveren.

Deze expertise is nodig.

- Verpleegkundigen en verzorgenden zijn een onderdeel van het begeleidings- en/of zorgteam.
- De basishouding van de zorgverlener draait om acceptatie van de klant en het kijken naar wat wél kan, vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid.
- Kennis en ervaring van mensen met ernstige multiproblematiek op alle levensgebieden.
- AVG/psychiater/SO vanuit multidisciplinair team.
- Nauwe samenwerking met huisarts.
- Vroegsignaleringsmethoden.
- De-escalerend werken.
- Balanceren tussen gevoel van eigen autonomie tot overname zorg indien nodig.

C. Besloten wonen.

Profiel van deze klantgroep (kenmerken kunnen, maar hoeven niet allemaal aanwezig te zijn)

- Veelal sprake van triple problematiek zoals psychiatrische aandoening (vaak EPA-diagnose), verslaving én LVB/zwakbegaafdheid (IQ < 85).
- Hoge mate van therapieresistentie.
- Behoeft een beschermd en besloten woonomgeving omdat bij ontbreken van deze structuur en nabijheid teloorgang, verwaarlozing en toename middelengebruik snel tot stand komt.
- Veelal voorgeschiedenis van langdurige klinische opnames, vaak bij meerdere instellingen.
- Er is sprake van ernstige gedragsproblematiek in het verleden en bij acute ontregeling. Dit uit zich in problemen met impulsregulatie, agressie en psychose. Ook kunnen automutilatie en suïcidaliteit voorkomen. Daarnaast is er soms sprake van seksueel ontremd gedrag of een verhoogd risico op misbruik. In sommige situaties is er sprake van ernstige zelfverwaarlozing of desorganisatie.
- Forse belemmering in dagelijks functioneren, veelal geen perspectief op zelfstandig wonen.
- Deze klanten vallen vaak tussen wal en schip bij reguliere GZ- of GGZ-woonvoorzieningen en hebben regelmatig te maken met complexe somatische co morbiditeit.

Kenmerken van het milieu/de context.

- Besloten woonvoorziening met intensieve woonbegeleiding met behandeling.
- Integratie van wonen en zorg met 24-uurs woonbegeleiding en laagdrempelige inzet van behandelaren zoals psychiater SPV en GZ-psycholoog georganiseerd binnen de locatie of via een FACT-team met meer intensiteit en nabijheid dan gebruikelijk.
- Zeer voorspelbare dag structuur, gericht op stabiliteit, vertrouwen en het bieden van een 'thuis'.
- Woonomgeving is huiselijk ingericht, inclusief gezamenlijke keuken, inloopruimte en bijvoorbeeld een prettige tuin.
- De doelgroep is kwetsbaar en vraagt om snelle opschaling naar klinische zorg om de veiligheid van klanten en woonlocatie te waarborgen ook alsnog niet aan de criteria voor spoedopname wordt voldaan.
- Langdurige en duurzame woonplek met nadruk op behoud van woonsituatie, niet op uitstroom.
- Het vertrekpunt is om niet meer te hoeven verhuizen.
- WvGGZ-maatregelen zijn integraal onderdeel van de woon- en begeleidingsplannen.
- Team werkt met methodiek en gedragsstrategieën die ontwikkeld zijn vanuit jarenlange klinische ervaring met de doelgroep. Deze staan bijvoorbeeld vormgegeven in de signaleringsplannen.
- Mogelijkheid tot interne dagbesteding en samenwerking met externe partijen voor verdere invulling. Focus op dagbesteding staat voorop en vormt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse structuur.
- Controle op middelengebruik (BAC/urinecontrole) en medicatie-inname onder toezicht.
- Woonvorm als "kliniek in de wijk" (ambulante zorg met klinische nabijheid).

Deze expertise is nodig.

- Bejegening en benadering vanuit gelijkwaardigheid, veiligheid en acceptatie.

- Methodisch werken met individuele begeleidingsplannen, herstelgerichte zorg en structuur.
- Interprofessionele samenwerking en korte communicatielijnen tussen wonen en behandelen.
- Kennis van Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en zwakbegaafdheid, met aandacht voor disharmonisch intelligentieprofiel.
- Kennis van rouw, verlies, trauma en hechtingsproblematiek.
- Psychofarmacologie en begeleiding bij medicatie-inname.
- Begeleiding bij verslavingsproblematiek (controle, preventie, omgaan met terugval).
- Ervaring met en uitvoering van WvGGZ-maatregelen in een woonsetting.
- De-escalatie en agressieregulatie-technieken.
- Specialistische GGZ-behandeling gericht op EPA (schizofrenie, bipolair, PTSS, OCD) is beschikbaar vanuit nauwe samenwerking met een GGZ behandelpartij.

Kaders voor indienen plan van aanpak.

Om voor tegemoetkoming in de financiering in aanmerking te komen verwachten wij een plan van aanpak.

Het plan van aanpak bevat de volgende onderdelen:

- De doelgroep waar het aanbod voor gerealiseerd wordt.
- Het aantal plekken.
- Planning realisatie nieuw aanbod.
- Wijze van realisatie, bijvoorbeeld verbouwing, organiseren vastgoed en inrichting, opleiding en beschikbaarheid en/of werving personeel.
- De locatie van het nieuwe aanbod.
- Een businesscase waarin ook de totale benodigde financiering inzichtelijk is, en het bedrag dat aangevraagd wordt vanuit het budget gericht contracteren.
- Voor vragen over het plan van aanpak kan contact worden opgenomen met het inkoopteam.
- Aanvullende informatie met betrekking tot gericht contracteren

Financieringsmogelijkheden.

Gericht Contracteren biedt incidentele, tijdelijke en een eenmalige financiering van opstartkosten die bijdragen aan nieuwe zorgplekken. Structurele zorgkosten vallen onder de reguliere vergoedingen. Cofinanciering is het uitgangspunt. Financiering is onder andere mogelijk voor:

- Extra verbouwingskosten
- Extra scholing en opleiding van personeel
- Extra inhuur van specialistisch personeel
- Inzet van een projectleider
- Kosten voor aanloop leegstand

(Financiële) kaders.

- Uitbetaling van het toegekende budget gebeurt op basis van afspraken die worden vastgelegd in een addendum bij de overeenkomst.
- Kosten blijven binnen de 100 procent NZa-tarieven van de kassier.
- Budget wat is uitgekeerd en niet benut door de zorgaanbieder wordt terugbetaald en vloeit terug in de contracteerruimte.
- Voorwaarde voor een afspraak is dat u beschikt over een meerjarige overeenkomst met het zorgkantoor.